Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves

Av. Presidente Costa e Silva, 315 - Bairro: Planalto - CEP: 95703260 - Fone: (54) 3452-2234 - Email: frbentgonc3vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5004151-78.2022.8.21.0005/RS

REQUERENTE: IULLE PINHEIRO PIOVESANA

REQUERIDO: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

SENTENÇA

Vistos.

IULLE PINHEIRO PIOVESANA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada em face de **UNIMED NORDESTE – RS.** Narrou que é beneficiária do Plano de Assistência à Saúde na categoria empresarial, operado pela requerida. Referiu que está grávida de 07 semanas, entretanto descobriu que sofre de Trombofilia, doença que possibilita a interrupção da gestação, bem como risco de morte à parturiente. Alegou que em razão da grave patologia, necessita de solução injetável denominada Enoxoparina 40mg, durante toda a gestação e 40 dias após o parto. Alegou que o referido remédio tem um custo muito elevado e que não tem condições de arcá-lo. Discorreu acerca do direito aplicável ao caso em tela. Colacionou jurisprudência. Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita; a tutela antecipada; a inversão do ônus da prova; a oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal do representante legal da requerida; e a total procedência da ação. Juntou documentos (evento 01).

Deferida a assistência judiciária gratuita (evento 03).

O Ministério Público dispensou intervenção no feito (evento 06).

Deferido o pedido de tutela provisória de urgência no evento 09.

A autora interpôs embargos de declaração no evento 11.

Julgado procedentes os embargos de declaração (evento 14).

Citada, a requerida apresentou contestação. No mérito, narrou acerca da ausência de cobertura para medicamento domiciliar. Referiu sobre o incontroverso caráter domiciliar do fármaco. Alegou referente a ausência de contratação específica e da inexistência de urgência no procedimento *sub judice.* Discorreu acerca do direito aplicável ao caso em tela. Colacionou jurisprudência. Requereu a oitiva de testemunhas; e a total improcedência da ação. Juntou documentos (evento 42).

A autora replicou no evento 47.

Intimadas as partes para se manifestarem no interesse de produzirem provas (evento 49).

A autora dispensou dilação probatória no evento 53, bem como a requerida (evento 54).

É o relatório.

DECIDO.

A presente demanda merece julgamento antecipado, uma vez que a matéria em discussão é exclusivamente de direito e os documentos juntados são suficientes para a solução da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Busca a parte autora, através da presente ação, o fornecimento do medicamento "enoxaparina 40 mg". Relata que está grávida de sete semanas e descobriu que sofre de trombofilia, doença que pode interromper a gestação e traz risco de morte à parturinete. Disse que em razão da gravidade da patologia, necessita do uso da solução injetável denominada "enoxaparina" durante toda a gestação até quarenta dias após o parto. Afirma que o valor do medicamento é elevado e não tem condições de suportar. Pede a procedência da ação com a condenação da ré ao fornecimento do tratamento.

A parte ré, por sua vez, afirma que se trata de medicamento de uso domiciliar, que não tem cobertura pelo plano de saúde.

Compulsando os autos vislumbra-se que a parte autora é portadora de trombofilia e necessita do uso do medicamento "enoxaparina" durante toda a gestação e na quarenta, sob risco de aborto (evento 1, ATESTMED11 e evento 1, ATESTMED12).

A controvérsia da lide cinge-se a responsabilidade da parte ré em fornecer o medicamento, já que ele é de uso domiciliar.

Quanto ao ponto, insta salientar que no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, foi decidido que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde. Veja-se:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.1. ***A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde.*** *O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito,* ***por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde****. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o* ***rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde****. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4.* ***O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população.*** *Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que* ***é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas****. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6.* ***O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico****. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020)*

Ainda, em recente julgamento (EREsp nº 1889704 / SP e EREsp nº 1889704/SP) o egrégio STJ firmou tese, determinando a taxatividade da rol de procedimentos/tratamento da ANS, restando consolidada as seguintes diretrizes , ***in verbis***:

(...)

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, ainda que por fundamentação diversa, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos quanto à tese da taxatividade os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. (...)

Por outro lado, a Lei n. 9.961/2000, criou a ANS com intuito de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar a saúde, competindo a ela regular as operadoras de saúde. Especificamente no art. 4º, I e III, consta a disposição legal de que compete à ANS ***in verbis***:

> *I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;*
>
> ***III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades;***
>
> *XXVI - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos;*
>
> *XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;*
>
> *XXXVI - articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990; XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar.(...)*

Desse modo, restou legalmente estabelecido que é competência legal da ANS, dentre outras, a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde.

Em 24-02-2021, a ANS aprovou a Resolução Normativa n. 465/2021, atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, momento em que definiu as coberturas mínimas que devem ser observadas pelos planos de saúde, em cotejo com as disposições da Lei n. 9.656/98, assim como, incluindo novos exames e tratamentos e estabelecendo, inclusive, a taxatividade do rol, veja-se:

> *Art. 2º Para fins de cobertura,* ***considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos,*** *podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.*

Dessa forma, para que seja determinada a cobertura do tratamento, é necessário que ele conste no referido rol, como sendo de cobertura obrigatória. Nesses casos, eventual cláusula que determine a exclusão do tratamento é nula de pleno direito, a teor do disposto nos arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa nº 465/2021 exarada pela ANS, contém o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, nos termos da Lei nº 9.656/98, *in verbis:*

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;*
>
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
>
> *III - inseminação artificial;*
>
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
>
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*
>
> *VIII - Revogado Pela Medida Provisória nº 2.177-44 de 2001.*
>
> *IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
>
> *X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.*

Percebe-se, portanto, que é lícito ao plano de saúde negar o fornecimento de medicamentos de tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.

A vedação, entretanto, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual.

Por outro lado, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS, que assim dispõe:

Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN dispõe sobre os princípios para oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde pelas operadoras de planos de assistência à saúde.

Parágrafo único. As medicações que aludem esta RN devem ter seus registros ativos, de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Art. 2º A presente RN aplica-se a todos os contratos individuais, familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais celebrados a partir de 2 de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 3º As operadoras de planos de assistência à saúde poderão, facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na presente RN.

§ 1º Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.

§ 2º As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam à oferta de medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.

No caso dos autos, extrai-se que o medicamento postulado, "enoxaparina 40mg", indicado para o tratamento de trombofilia, pertence à classe dos medicamentos "antitrombóticos" e sua administração, embora injetável, é de uso domiciliar.

Ocorre que, alem do disposto na RN 465/2021, o contrato celebrado pelas partes exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar:

XIII - EXCLUSÕES DE COBERTURA

Cláusula 15ª - Em conformidade com o que prevê a Lei nº. 9656/98, e respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estão excluídos da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANs vigente à época do evento para a segmentação assistencial contratada e os provenientes de:

(...)

III - Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais e os para o controle de efeitos adversos constantes no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente à época do evento; (evento 42, CONTR5).

Assim, considerando que não há previsão de obrigatoriedade de cobertura no fornecimento de medicamentos domiciliares, não afigura-se equivocada ou ilícita a negatica de fornecimento, já que fundamentada no previsto em contrato e na legislação de regência.

Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.
Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido.
(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

No mesmo sentido, o entendimento do E. TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA GESTANTE E PORTADORA DE TROMBOFILIA. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA (60 MG E 40 MG). AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS OBRIGATORIEDADES LEGAIS. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedentes os pedidos e condenou a apelante a fornecer à autora os medicamentos Enoxaparina 60mg e 40mg, enquanto necessário ao seu tratamento, condenou a apelante ao pagamento do dano material suportado pela autora, bem como condenou a apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais. 2. As Turmas do E. STJ divergem quanto à natureza do rol de procedimentos da ANS, não se verificando a alegada superação de precedente (overruling). Este colegiado, porém, possui entendimento consolidado de que o rol da ANS tem natureza taxativa, alinhando-se ao posicionamento da Quarta Turma do E. STJ. Precedentes. 3. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos para

tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimentos mínimos da ANS para esse fim (art. 10, VI, § 1º, e art. 12, I, c, II, g, ambos da Lei nº 9.656/98; art. 17, parágrafo único, VI, e art. 18, IX e X, a e b, ambos da Resolução nº 465/2021 da ANS). 4. ***No caso concreto, os medicamentos postulados (Enoxaparina 60mg e 40mg) para o tratamento da autora são de uso domiciliar, não se enquadram nas obrigatoriedades legais e não possuem previsão contratual de cobertura, de modo que a operadora de plano de saúde ré não deve ser compelida a custear o seu fornecimento. Sentença reformada.*** *5. Invertidos os ônus sucumbenciais diante do resultado do julgamento. Autora condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50005224620208210109, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Julgado em: 28-04-2022)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TROMBOFILIA. MEDICAMENTO ENOXAPARINA. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 3) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 4) Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Enoxaparina 60mg", indicado para o tratamento de Trombofilia, pertence a classe dos medicamentos "Antitromboticos" e sua administração, embora injetável, é de uso domiciliar. 5) ***Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, descabe compelir a operadora do plano de saúde à cobertura do medicamento domiciliar postulado.*** *Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50223385620218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-06-2022)*

Destarte, impõe-se a improcedência da ação.

ISTO POSTO, fulcro no disposto no art. 487, I do CPC, **REVOGO** a liminar e **julgo IMPROCEDENTE** a ação ajuizada por IULLE PINHEIRO PIOVESANA contra UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA, pelos fatos e fundamentos acima explicitados.

Condeno a parte autora ao pagamento da taxa única de serviços judiciais e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa, o que faço com fundamento no artigo 85, §2º, do novo Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN, Juíza de Direito**, em 28/7/2022, às 14:45:8, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10022815082v10** e o código CRC **02c3dd0b**.